

腹壁韧带样瘤诊治特点(附 15 例报告)

顾伟青 王 强 杨徐雄

【摘要】 目的 探讨腹壁韧带样瘤的临床特点及诊治方法。**方法** 回顾性分析从 2001 年 8 月~2011 年 8 月在我院手术治疗的 15 例腹壁韧带样瘤的临床资料,研究其诊治特点和效果。**结果** 15 例本组患者都进行手术治疗,所有手术均顺利完成,无并发症。随访时间内,有 2 例术后复发,无转移病例和因该肿瘤死亡病例。**结论** 腹壁韧带样瘤一种罕见的纤维组织肿瘤,易复发、无转移。可根据临床特点做出初步诊断,MRI 是首选影像检查,确诊需要根据术后病理学检查。手术切除为首选治疗方法,术中要有足够的切缘,术后要密切随访。

【关键词】 腹壁 韧带样瘤 手术

Diagnosis and treatment of abdominal wall desmoids tumor (report of 15 cases) GU Wei-qing, et al.
(Department of Oncology, Mindong Hospital Affiliated to Fujian Medical University, Fujian 355000, the P. R. China.)

【Abstract】 Objective To approach the clinical feature and diagnosis and treatment of abdominal wall desmoids tumor. **Methods** From August 2001 to August 2011, clinical data of 15 cases of abdominal wall desmoids tumor were retrospectively analyzed. The feature and effect of diagnosis and treatment was studied. **Results** All patients were successfully operated without complications. During followup, there were 2 cases of recurrence, no case of metastases and dying of tumor. **Conclusions** Abdominal wall desmoids tumor was a rare fabric tumor, which was easy to recur and unable to metastase. Abdominal wall desmoids tumor can be primarily diagnosed by clinical feature. MRI is the optimal imaging examination. But the final diagnosed depend on pathology. Surgical resection is the optimal treatment. Sufficient cutting edge and intimate followup after operation is required.

【Key words】 Abdominal Wall Desmoids Tumor Operation

腹壁韧带样瘤是一种罕见的纤维组织肿瘤,虽然组织形态良好,但浸润生长,易复发,无转移^[1],生物学行为属于低度恶性,临床上诊治有一定难度。2001 年 8 月~2011 年 8 月,本院肿瘤科共收治腹壁韧带样瘤 15 例,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 本组 15 例,其中女 13 例,男 2 例,年龄 20~45 岁,平均(34.3 岁);病程 1~42 个月,13 例女性患者中未婚 1 例,其他患者均已婚并有妊娠生育史。其中,生育 1 胎 9 例,生育 2 胎 2 例,生育 3 胎 1 例。有剖腹产史者 5 例。2 例男性患者均有腹部外伤史。全部患者都以腹壁无痛性肿块为主诉就诊,且肿块呈进行性缓慢增大。肿块位于右上腹 2 例,左上腹 2 例,左下腹 9 例,右下腹 2 例。直径 3~6 cm,平均 3.8 cm。全部患者均行 B 超检查和 MRI 检查。

1.2 治疗方法 全部患者均行外科手术治疗,术中距离肿瘤边缘 2~3 cm 完整切除肿瘤,其中 2 例患者肿块较大,侵及腹直肌后鞘、腹膜,切除受浸润组织,由于腹壁缺损过大用人工材料修补。术后常规送病理检查,有 2 例切缘阳性的术后 1 个月行局部放疗。

2 结果

所有手术均顺利完成,无感染和切口疝等并发症发生。全部患者获得随访,随访时间 13 个月~120 个月;切缘阳性

的 2 例术后复发,其中 1 例术后 16 个月复发,另 1 例术后 25 个月复发,予再行手术切除,术后切缘阴性,并予放疗,随访至今未见复发和转移。2 例腹壁缺损过大用人工材料修补者无腹壁切口疝发生。本组无转移病例和因该肿瘤死亡病例。

3 讨论

韧带样瘤是一种罕见的纤维组织肿瘤,发病率在 2~4/100 万^[2],它的发病率在实体瘤中约占 0.03%^[3]。韧带样瘤可以发生于身体多个部位,可以根据其生长部位分为腹壁型、腹内型和腹部外型三种。该病多见于年轻育龄期女性,且多见于腹壁。病因尚不很明确,可能的病因有:1)内分泌:文献报道,在动物实验中雌激素可诱发韧带样瘤形成,而睾丸酮和孕酮可抑制肿瘤形成。也有学者发现进入绝经后期或经过卵巢去势,部分患者肿瘤可自动消退,说明该病与雌激素水平呈正相关。本组患者中有 80% 的患者有生育史,也提示本病与内分泌有关。2)遗传:本病有一定的遗传倾向,特别是家族性腺瘤性息肉病患者的家属中发生率达 8%~38%,要注意排查^[2]。3)创伤:有学者认为,外伤、手术、妊娠、分娩等创伤是诱发因素,本组病例韧带样瘤也多发于原手术切口及邻近区域。

本病根据以下临床特点可做出初步诊断:1)好发于有妊娠生育、腹部手术或外伤史的患者,以女性多见。2)肿块多为生长缓慢的无痛性圆形或类圆形肿块,质较硬,边界欠清,较固定。当诊断困难时,B 超、CT 及 MRI 检查可协助诊断,并可以了解肿块的位置及侵犯范围,指导制定手术方案。在各

糖尿病患者康复治疗探讨

兰 翠

【摘要】 目的 探讨以量化运动为主的康复疗法治疗 2 型糖尿病的疗效。**方法** 对 2009 年 1 月~2011 年 12 月在我院就诊的 100 例 2 型糖尿病患者的临床资料进行回顾性分析。**结果** 行以量化运动为主的康复疗法 3 个月后,2 型糖尿病患者的空腹、餐后 2 h 血糖及糖化血红蛋白等指标明显下降,体重、BMI 及体质百分率也明显下降 ($P < 0.05$)。**结论** 康复治疗中量化运动的应用,可提高糖尿病患者运动依从性,显著改善其血糖、体质指标,值得深究推广。

【关键词】 糖尿病 量化运动 康复治疗

糖尿病属(Diabetes mellitus)常见的内分泌代谢类疾病,多由遗传、环境等因素相互作用而致^[1],随着我国物质水平的不断提升,人们的生活习惯明显改变,致糖尿病发病率呈明显上升趋势^[2]。糖尿病主要分为 1 型和 2 型,其中 1 型多因胰岛 β 细胞被选择性破坏,致胰岛素缺乏,需行终身胰岛素治疗;而 2 型多由肥胖等因素致胰岛素分泌不足,不需即行胰岛素治疗,可先予以饮食、运动疗法及药物治疗,控制血糖异常升高情况,若疗效不佳,再予以胰岛素治疗。本文对 2009 年 1 月~2011 年 12 月在我院就诊的 100 例 2 型糖尿病患者的临床资料行回顾性分析,探讨以量化运动疗法为主的康复治疗疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组 100 例 2 型糖尿病患者,排除糖尿病足、糖尿病肾病者,排除合并其他脏器严重并发症者,其中男 41 例,女 59 例;年龄 35~60 岁,平均 (48.6 ± 4.9) 岁;病程 1~5 年,平均 (2.8 ± 1.6) 年;身高 $1.48 \sim 1.78$ m,平均 (1.61 ± 0.08) m;体重 $49.9 \sim 85.1$ kg,平均 (72.1 ± 6.6) kg;体重指数(BMI) $24.1 \sim 36.9$ kg/m²,平均 (30.9 ± 3.1) kg/m²。根据治

疗方式不同分组,观察组 50 例予以康复治疗,对照组 20 例予以常规治疗,两组患者在年龄、病程、BMI 等一般资料方面差异均无显著性 ($P > 0.05$),具有可比性。

1.2 方法 两组患者均予以常规饮食疗法和药物治疗,饮食疗法:严格控制每日热量摄入量,以可维持标准体重为度;合理搭配碳水化合物(50%~60%)、蛋白质(15%~20%)及脂肪(25%~30%)的摄入^[3];予以充足的食物纤维素、维生素及适量无机盐等;强调保持良好饮食习惯的重要性,需按时、定量、细嚼慢咽进食,少或不食零嘴。药物治疗以口服降糖药为主,予以磺脲类药物,刺激胰岛素释放,同时予以双胍类药物,减轻胰岛素抵抗。

观察组另行量化运动康复治疗,根据患者病况及耐受力不同,制定相应的运动方案,方法依次是以肌肉伸展及关节牵伸运动为主、以改良太极拳为主、以无或低冲击力的有氧保健体操动作为主及以低冲击为主并适当增加一些高冲击动作等,运动强度由小到大。所有患者在专门人员带领下运动,于晚餐后 1 h 从强度最小的运动开始,每种方法运动时间为 1 h,连续进行 3 d,同时监测患者运动前后心率、血压、血氧饱和度、血糖及疲劳程度等指标,3 d 后结合上述指标情况,选择最适合患者个体的运动方法锻炼 3 个月。

1.3 观察指标 评估 2 型糖尿病患者运动 3 个月前后血糖、

作者单位:广西脑科医院,柳州

邮 编 545005 收稿日期 2012-09-21

种影像检查手段,MRI 对软组织的分辨率较高,可以清晰显示肿瘤与周围血管、神经和重要脏器的关系,并且在 T₁WI 和 T₂WI 上及增强扫描图像上,因含胶原纤维多,显示为低信号纤维成分,可以与软组织恶性肿瘤相鉴别,是术前评价肿瘤及术后监测复发的首选检查。确诊需要根据术后病理,其术后的病理组织学特征:镜下肿瘤中胶原纤维多,可见细胞外胶原纤维明显增生。纤维细胞占比例少,以成纤维母细胞为主,部分有肌成纤维细胞特征。当然本病还应注意与纤维肉瘤、腹壁疝、结外淋巴瘤、平滑肌瘤等鉴别。

手术切除为该病的首选方法,由于本病具有侵袭性生长和术后容易复发的特点,有报道局部复发率高达 25%~60%^[4-5],所以要求完整切除肿物,并切除肿瘤周围 3 cm 以上的正常组织,必要时切除部分腹膜、肌肉及腱膜。如果肿瘤切除后腹壁缺损较大,目前可用聚丙烯补片或复合补片修补^[6],本组 2 例切缘阳性术后复发,也说明安全切缘的重要性,要引起我们足够的重视。针对非手术治疗,如放射治疗、内分泌治疗,目前尚有争论,不作为常规治疗。对于切缘阳性者建议术后常规行放射治疗。总之,该病治疗上要以低度恶

性的软组织肿瘤处理原则进行,术中要保证足够的切缘,它是预防本病术后复发的关键,且术后要长期密切随访,做到早发现,早治疗。

参 考 文 献

- [1] Berri RN, Baumann DP, Madewell JE. Desmoid tumor: current multidisciplinary approaches[J]. Ann Plast Surg, 2011, 67(5):551-564
- [2] 林辉,曹利平. 腹壁韧带样瘤的诊治进展[J]. 中国实用外科杂志, 2004, 24(8):499-501
- [3] 黄玉钿. 韧带样瘤病理诊断 7 例分析[J]. 中国误诊学杂志, 2005, 5(12):23-24
- [4] Shinagare AB, Ramaiya NH, Jagannathan JP, et al. A to Z of desmoid tumors[J]. AJR Am J Roentgenol, 2011, 197(6):1008-1014
- [5] 孙国志,王猛,朱卫红. 腹壁韧带样瘤 16 例临床分析[J]. 中华疝和腹壁外科杂志(电子版), 2012, 6(1):578-582
- [6] Catania G, Ruggeri L, Iuppa G, et al. Abdominal wall reconstruction with intraperitoneal prosthesis in desmoid tumors surgery[J]. Updates Surg, 2012, 64(1):43-48